

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

RV-PLUTCHIK · ESCALA DE RIESGO DE VIOLENCIA

Plutchik's Risk of Violence Scale – Protocolo autoinformado de cribado de agresividad física, impulsividad y riesgo heteroagresivo

1. Identificación General del Instrumento

Nombre oficial	Plutchik's Risk of Violence Scale (RVS)
Nombre en español	Escala de Riesgo de Violencia de Plutchik
Sigla oficial	RV-Plutchik (RVS)
Autores originales	Robert Plutchik y Herman M. van Praag (1990)
Adaptación hispanohablante	G. Rubio, M. Morales, A. Rubio, J. Cabrerizo, J. L. San Román et al. (1998)
Año de publicación original	1990 (adaptación española en 1998)
Constructo primario	Riesgo de violencia física, sentimientos agresivos, antecedentes delictivos y acceso a armas
Formato de administración	Autoinforme estructurado de 12 ítems (escala ordinal 0-3 y dicotómica)
Población diana	Adultos y adolescentes (≥ 16 años) en psiquiatría clínica, forense, adicciones y urgencias
Tiempo de aplicación	3 a 5 minutos (12 ítems)
Régimen de acceso	Uso clínico y académico abierto de dominio público con fines de salud y periciales

2. Fundamentación Conceptual y Marco Clínico

La **Escala de Riesgo de Violencia de Plutchik** (RV-Plutchik) es el instrumento complementario desarrollado por Robert Plutchik y Herman M. van Praag para la evaluación de la agresión dirigida hacia otros (**outward-directed aggression**), formando un continuo etiopatogénico con la conducta suicida en virtud de la hipótesis de la disfunción serotoninérgica y el déficit de control inhibitorio común a ambas manifestaciones violentas.

La escala fue diseñada con el fin de discriminar entre pacientes con potencial de conducta violenta física inminente y pacientes no agresivos en contextos hospitalarios, comunitarios y forenses. El marco teórico de Plutchik postula que el riesgo violento es el resultado de la interacción entre tres vectores clave: 1) la frecuencia e intensidad de la activación afectiva iracunda sin justificación proporcional; 2) la historia previa de violencia física real (peleas, agresiones intrafamiliares y empleo de objetos contundentes); y 3) la disponibilidad material de armas y el historial de transgresión delictiva. Por su extrema brevedad y valor discriminante, se ha consolidado como la herramienta de cribado preliminar de heteroagresividad de referencia en lengua española.

3. Dominios Evaluados y Composición de Ítems

Dimensión / Factor	N.º Ítems	Rango	Contenido Clínico y Operacionalización
1. Reactividad y Cólera	3 ítems	0 – 9	Ítems 1 (enfado fácil), 2 (enfado continuo con los demás) y 3 (enfurecimiento sin motivo aparente). Labilidad afectiva.
2. Violencia Física y Objetos	5 ítems	0 – 15	Ítems 4 (empuñar armas al enfadarse), 5 (lesionar a alguien en pelea), 6 (agresión a familiar), 7 (agresión a extraños) y 8 (uso de objetos).
3. Antecedentes Delictivos	2 ítems	0 – 6	Ítems 10 (detenciones por delitos no violentos) y 11 (detenciones por delitos violentos: asalto, robo a mano armada).
4. Acceso y Tenencia de Armas	2 ítems	0 – 6	Ítems 9 (facilidad para conseguir un arma, 0-3) y 12 (guarda armas en casa y sabe usarlas, calificado 0 o 3).
Puntuación Total RV	12 ítems	0 – 36	Suma directa de las puntuaciones de los 12 ítems. Corte clínico hispano: ≥ 4 puntos.

4. Validez, Confiabilidad y Rendimiento Diagnóstico en España / LatAm

Propiedad Métrica	Coefficiente / Hallazgo	Contexto Empírico y Validación Hispana
Consistencia interna	Alpha de Cronbach = 0.85 – 0.88	Adecuada consistencia interna en la validación española de Rubio et al. (1998) en población penitenciaria y psiquiátrica.
Fiabilidad test-retest	r = 0.82 (intervalo de 1 semana)	Estabilidad temporal adecuada para patrones estables de agresividad y conducta antisocial.
Sensibilidad diagnóstica	75.0% – 82.0% (corte ≥ 4)	Identifica correctamente a la gran mayoría de sujetos con episodios reales de violencia física.
Especificidad diagnóstica	70.0% – 78.0% (corte ≥ 4)	Capacidad adecuada para discriminar pacientes sin riesgo heteroagresivo.
Validez convergente	r = 0.61 con BDHI (Buss-Durkee); r = 0.54 con BIS-11	Correlación positiva con escalas de hostilidad y motricidad impulsiva.
Validez prospectiva	Riesgo relativo = 3.2 (p < 0.01)	Mayor tasa de incidentes violentos en salas de agudos en pacientes con puntuaciones ≥ 4 al ingreso.

5. Reglas de Corrección y Cómputo de Puntuaciones

- **Ítems 1 al 11:** Se califican en una escala ordinal de frecuencia de 4 anclajes: 0 = **Nunca**; 1 = **A veces**; 2 = **A menudo**; 3 = **Casi siempre**.
- **Ítem 12 (Tenencia de armas en el hogar y manejo):** Se califica en formato dicotómico ponderado: **NO = 0 puntos** | **SÍ = 3 puntos**. (En algunas adaptaciones se utiliza 0-1, pero el protocolo estandarizado de Rubio et al. y Bobes et al. asigna 3 puntos a la respuesta afirmativa por su severidad predictiva).
- **Puntuación Total:** Suma directa simple de los 12 ítems, con un rango total de 0 a 36 puntos.
- **Ítems Críticos de Alarma:** Respuestas superiores a 0 en los ítems 4 (**empuñar armas**), 6 (**agresión a familiares**), 8 (**uso de objetos lesivos**) o 12 (**posesión de armas**) obligan a una intervención de seguridad inmediata sin importar el puntaje total.

6. Baremos Normativos, Puntos de Corte y Estratificación Clínica

Puntuación Total	Estratificación de Riesgo	Significación Clínica e Indicación Asistencial
0 – 3 puntos	Riesgo Bajo / Ordinario	Sin evidencia de reactividad hostil o conductas agresivas desadaptativas. Manejo ordinario.
4 – 7 puntos	Riesgo de Violencia Moderado	Punto de corte clínico hispano (≥ 4). Riesgo significativo de altercados físicos y pérdida de control. Requiere intervención psicoconductual y cautela.
8 – 14 puntos	Riesgo de Violencia Elevado	Frecuentes agresiones físicas, antecedentes delictivos o empuñamiento de objetos. Alerta de seguridad para el personal sanitario y familiares.
15 – 36 puntos	Riesgo Crítico / Inminente	Patrón consolidado de heteroagresividad grave, antecedentes de asalto armado o tenencia activa de armas. Alto potencial lesivo. Medidas de contención.

PUNTO DE CORTE DE REFERENCIA (RUBIO ET AL., 1998): Una puntuación total ≥ 4 puntos discrimina con precisión clínica a pacientes con propensión a la violencia física frente a sujetos sin antecedentes, exigiendo una valoración pormenorizada del entorno de convivencia y de la posesión de armas.

7. Algoritmo de Decisión Clínica e Intervención Asistencial

Paso 1: Aplicación del cribado RV-Plutchik:

- Administrar en urgencias o consulta ante cuadros de intoxicación alcohólica/estimulantes, trastornos psicóticos agudos, trastorno límite o antisocial de la personalidad.

Paso 2: Evaluación contextual de seguridad ambiental:

- **Si ítem 12 = 3 (Posee armas):** Coordinar con familiares o autoridades la retirada o entrega inmediata de cualquier armamento del domicilio.
- **Si ítem 6 ≥ 1 (Violencia intrafamiliar):** Valorar riesgo de violencia doméstica y protección de víctimas vulnerables (pareja, menores, ancianos).

Paso 3: Vía clínica y terapéutica según estratificación:

- **RV < 4:** Abordaje psicoterapéutico estándar sin medidas especiales de contención.
- **RV 4 – 7:** Entrenamiento en control de la ira, desescalada verbal, evitar confrontación directa y revisión de pauta psicofarmacológica (ej. antiimpulsivos, estabilizadores del ánimo).
- **RV ≥ 8:** Garantizar seguridad del personal sanitario (espacio físico despejado, puerta de salida accesible, presencia de seguridad). Si hay descompensación psicótica, valorar ingreso hospitalario urgente.

8. Caso Clínico Ilustrativo

Identificación: Varón de 28 años, con diagnóstico de Trastorno por Uso de Cocaína y rasgos de personalidad antisocial, derivado por orden judicial a un Centro de Atención a las Drogodependencias (CAD) tras un altercado en vía pública.

Resultados en la Escala RV-Plutchik:

- Puntuación Total: **11 puntos / 36** (Riesgo de Violencia Elevado).
- Puntuaciones destacadas: Ítem 1 = 3 (se enfada continuamente), Ítem 3 = 2 (se enfurece sin motivo aparente), Ítem 5 = 2 (ha lastimado a personas en peleas de bar), Ítem 7 = 2 (ha pegado a personas no familiares), Ítem 10 = 2 (antecedentes por detenciones de tráfico y desórdenes públicos).
- Ítems 4, 8 y 12 puntuados con 0 (no posee armas ni ha usado objetos letales).

Manejo Clínico y Evolución: La puntuación de 11 confirmó un patrón de impulsividad motora descontrolada agravado por el consumo de tóxicos. Se estableció un plan asistencial centrado en: 1) desintoxicación ambulatoria intensiva con controles toxicológicos en orina; 2) prescripción de estabilizador del ánimo (Topiramato) para regular el impulso agresivo; 3) derivación a un grupo de manejo de la ira y habilidades sociales. A los 3 meses de abstinencia continuada y terapia conductual, el puntaje en la RV descendió a 3 puntos, sin nuevos incidentes violentos registrados.

9. Alertas de Seguridad y Diagnóstico Diferencial

ALERTAS DE RIESGO FORENSE / CLÍNICO:

- **Comorbilidad con consumo de sustancias:** El alcohol y los psicoestimulantes multiplican exponencialmente el riesgo violento en sujetos con $RV \geq 4$.
- **Descompensación psicótica activa:** Delirios de persecución o alucinaciones imperativas combinadas con RV elevada constituyen una urgencia psiquiátrica de alto riesgo lesivo.
- **Protección del evaluador:** No entrevistar a solas en espacios cerrados sin salida directa a pacientes con $RV \geq 8$.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

- **Violencia instrumental vs. Reactiva:** La RV evalúa predominantemente agresividad impulsiva y reactiva; los psicópatas primarios pueden puntuar bajo por cálculo manipulativo.
- **RV vs. HCR-20 v3:** La RV es un cribado rápido autoinformado (3 min); no reemplaza a evaluaciones forenses exhaustivas multi-fuente como el HCR-20.
- **Agitación orgánica:** Descartar cuadros confusionales o traumáticos en ancianos antes de atribuir la conducta a rasgos caracteriales.

10. Referencias Bibliográficas Científicas

1. Plutchik, R., & van Praag, H. M. (1990). A self-report measure of violence risk, II. *Comprehensive Psychiatry*, 31(5), 450–456. [https://doi.org/10.1016/0010-440X\(90\)90030-S](https://doi.org/10.1016/0010-440X(90)90030-S)
2. Rubio, G., Morales, M., Rubio, A., Cabrerizo, J., San Román, J. L., & Bousoño, M. (1998). Validación de la escala de riesgo de violencia de Plutchik en población española. *Archivos de Neurobiología*, 61(3), 205–214.
3. Bobes García, J., G-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3.ª ed.). Ars Medica / Psiquiatría Editores.
4. Douglas, K. S., Hart, S. D., Webster, C. D., & Belfrage, H. (2013). *HCR-20V3: Assessing risk for violence*. Mental Health, Law, and Policy Institute, Simon Fraser University.